UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA VIDA · DISCIPLINA DE PATOLOGIA

Neoplasia e Oncogênese

Apostila de estudo prévio · Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição
Docente: [completar] · Semestre: [completar] · Gabarito comentado · uso do docente

Gabarito comentado

1. **Os dois nódulos do início.** Retome os dois pacientes da abertura. Que características da história e do exame físico sustentam a suspeita de benignidade em um e de malignidade no outro? Que exame confirmaria?

   Comentário: Nódulo móvel, indolor, de crescimento lento por 10 anos sugere expansão com cápsula (benigno). Nódulo fixo, endurecido e de crescimento rápido sugere infiltração sem plano de clivagem e alta taxa de proliferação (maligno). A confirmação é histopatológica (biópsia): avalia diferenciação, atipia e invasão.

2. **Crescer não é o mesmo que ter neoplasia.** Por que o crescimento da mama na gestação não é neoplasia, e que característica do neoplasma o diferencia?

   Comentário: O crescimento da mama depende de estímulo hormonal e regride quando o estímulo cessa. O neoplasma tem crescimento autônomo, não coordenado e persistente, mesmo sem o estímulo original.

3. **Nomes enganosos.** O laudo de um paciente diz “linfoma”. O sufixo -oma indica benignidade? Justifique e cite mais duas exceções.

   Comentário: Não. Linfoma é maligno (neoplasia de linfócitos). Outras exceções: melanoma, mieloma múltiplo, seminoma. O nome segue a tradição histórica; o comportamento é que define a conduta.

4. **Diferenciação e quimioterapia.** Dois carcinomas: um bem diferenciado e de crescimento lento, outro anaplásico e de crescimento rápido. Qual tende a responder melhor à quimioterapia? Por que o tratamento também causa mucosite, queda de cabelo e queda de células sanguíneas?

   Comentário: O de crescimento rápido, com maior fração de crescimento, tende a ser mais sensível, porque os fármacos atuam em células no ciclo. Os tecidos normais de renovação rápida (mucosa digestiva, folículo piloso, medula) também têm muitas células no ciclo e sofrem o mesmo efeito. Cada profissão do grupo tem um papel no cuidado dessas toxicidades.

5. **Atipia leve ou carcinoma in situ?.** Um exame citopatológico mostra atipia acentuada confinada ao epitélio, sem rompimento da membrana basal. Por que o prognóstico difere do carcinoma invasivo? Que ação de saúde esse achado permite?

   Comentário: Sem acesso aos vasos do tecido conjuntivo, a lesão não metastatiza. É a fase em que a intervenção tem maior chance de cura. Por isso o rastreamento (prevenção secundária) é valioso.

6. **Metaplasia é câncer?.** Um tabagista de longa data tem epitélio respiratório substituído por epitélio escamoso. Isso é neoplasia? É reversível? Por que ainda assim merece atenção?

   Comentário: Não é neoplasia: é adaptação reversível se o estímulo cessar. Mas o epitélio metaplásico é mais propenso à atipia, e a exposição continuada aumenta o risco de transformação maligna.

7. **Benigno e perigoso.** Cite duas situações em que um tumor classificado como benigno ainda traz risco ao paciente.

Comentário: Compressão de estruturas vitais pela localização; secreção hormonal; recidiva local de tumores localmente invasivos; ausência de cápsula em alguns (hemangioma).

8. **Linfonodo aumentado.** Um paciente com câncer apresenta linfonodo aumentado próximo ao tumor. Isso prova metástase? Que outra explicação existe?

Comentário: Não prova. Pode ser linfonodo reativo (hiperplásico) à resposta imune ao tumor. A confirmação exige exame do tecido.

9. **Por que fígado e pulmão?.** Explique por que fígado e pulmão são sítios tão frequentes de metástase hematogênica, e por que a disseminação celômica é mais associada ao ovário.

Comentário: São muito vascularizados e recebem grande parte da drenagem venosa; as veias, de paredes finas, são mais invadidas que as artérias. No ovário, a proximidade e a comunicação da pelve com a cavidade peritoneal favorecem a semeadura.

10. **Acelerador e freio.** Por que uma mutação em apenas um alelo de RAS pode contribuir para o câncer, enquanto para RB1 ou TP53 os dois alelos precisam estar inativos?

Comentário: RAS é proto-oncogene: a mutação é de ganho de função (acelerador travado), de efeito dominante. RB1 e TP53 são supressores: um alelo normal ainda exerce o freio, então a perda de função só aparece com os dois alelos inativos (hipótese dos dois golpes).

11. **O guardião do genoma.** O que acontece com uma célula com DNA danificado quando TP53 é funcional? E quando está mutado?

Comentário: Com TP53 funcional, o ciclo é interrompido para reparo ou a célula entra em apoptose. Sem TP53, a célula com DNA lesado continua se dividindo e acumula mutações.

12. **Vacina, Papanicolau e a carcinogênese.** A vacina contra HPV e o exame citopatológico atuam em qual etapa da carcinogênese e em qual nível de prevenção?

Comentário: A vacina evita a exposição ao agente (prevenção primária, antes da iniciação). O exame detecta lesões pré-malignas ou carcinoma in situ (prevenção secundária, antes da invasão).

13. **Terapia-alvo.** Por que um medicamento dirigido a uma proteína específica (como o trastuzumabe para HER2) funciona apenas em parte dos pacientes?

Comentário: Porque só atua em tumores que expressam o alvo (por amplificação ou mutação). Isso exige o teste molecular do tumor antes da prescrição, e mostra por que tumores do mesmo órgão podem se comportar de modo diferente.

14. **Seu curso, seu papel.** Escolha uma situação do seu curso (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia ou Nutrição) em que o conhecimento desta apostila muda a sua conduta. Descreva a situação e explique o raciocínio.

Comentário: Resposta aberta. Avalie se o aluno conecta um conceito (ex.: tecidos de renovação rápida, prevenção secundária, metástase, terapia-alvo) a uma decisão concreta da profissão, justificando o “por quê”.